

CAPÍTULO 1.5

Fibrilación Auricular

PERFIL EUNACOM 1.01.1.012

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

La **Fibrilación Auricular (FA)** es la arritmia más frecuente y su diagnóstico y manejo oportuno son cruciales para prevenir complicaciones graves.

Etiología y Factores de Riesgo

La causa subyacente de la FA influye significativamente en su pronóstico. El mecanismo principal es la dilatación de la aurícula izquierda, que desorganiza la transmisión de la onda de despolarización auricular, llevando a la fibrilación.

Causas Principales de Dilatación Auricular Izquierda:

- **Hipertensión arterial (HTA):** Es la causa más frecuente. La HTA crónica genera cardiopatía hipertensiva con hipertrofia concéntrica, disfunción diastólica y, finalmente, dilatación de la aurícula izquierda. - **Valvulopatías:** - La **estenosis mitral** es la valvulopatía que más dilata la aurícula izquierda y la que más se asocia a FA, con un alto riesgo embólico. - Cualquier valvulopatía izquierda puede aumentar el riesgo. - **Otras cardiopatías:** - Cardiopatías congénitas. - Cardiopatía coronaria. - Miocardiopatías.

Estados Hiperdinámicos y Aumento del Tono Simpático:

Cualquier condición que aumente la frecuencia cardíaca y el tono adrenérgico puede desencadenar FA, ya sea de forma aguda o mantenerla crónicamente. - Hipertiroidismo. - Sepsis. - Síndrome coronario agudo. - **Embolia pulmonar.** - Anemia. - Intoxicación por cocaína.

Causas Idiopáticas:

- Son aquellos casos en los que no se encuentra un desencadenante o explicación clara. - Son frecuentes, especialmente en pacientes jóvenes. - Generalmente tienen un mejor pronóstico.

Manifestaciones Clínicas y Complicaciones

La clínica de la FA es variada y sus complicaciones pueden ser muy serias.

Síntomas:

- **Palpitaciones:** Es el síntoma más común de taquiarritmia. - **Síntomas de insuficiencia cardíaca:** Disnea, fatiga. - **Fenómenos embólicos:** Son las complicaciones más importantes y temidas. Pueden manifestarse como: - **Accidente Cerebrovascular (ACV).** - Isquemia mesentérica. - Embolia de extremidad inferior. - Isquemia renal.

Hallazgos al Examen Físico:

- **Pulso irregularmente irregular:** Característico de la FA, la irregularidad es caótica y sin patrón. - **Ausencia de R4:** El cuarto ruido cardíaco (R4) se produce por la contracción auricular contra un ventrículo rígido; al no haber sístole auricular organizada en la FA, el R4 está ausente. - **Ausencia de onda 'a' en el pulso venoso yugular:** La onda 'a' representa la contracción auricular; en la FA, la actividad auricular desorganizada impide su formación.

Diagnóstico

El diagnóstico de la FA, al igual que la mayoría de las arritmias, se realiza mediante un **Electrocardiograma (ECG)**.

Hallazgos en el ECG:

- **Ritmo irregular:** Es el signo más evidente y rápido de identificar. - **Ausencia de onda P:** La actividad auricular desorganizada impide la formación de ondas P detectables. - **Ondas 'f' (de fibrilación):** La línea de base se reemplaza por oscilaciones rápidas, irregulares y de baja amplitud, que representan la actividad eléctrica fibrilatoria de las aurículas. - **QRS angosto:** Generalmente, el QRS es angosto (<0.12 segundos) ya que la FA es una arritmia supraventricular. Sin embargo, puede ser ancho si coexiste con un bloqueo de rama o una vía accesoria. - **Frecuencia ventricular variable:** Depende del grado de bloqueo auriculoventricular. Puede ser normal, alta o muy alta.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

FA vs. Flutter Auricular: - **FA:** Ondas 'f' irregulares en la línea de base, ausencia de onda P, ritmo irregular. - **Flutter Auricular:** Ondas 'F' (en "dientes de sierra") bien identificables y regulares (especialmente en V1 y derivaciones inferiores), con una relación de conducción AV fija (ej. 2:1, 3:1).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Una **FA con frecuencia cardíaca extremadamente alta** (respuesta ventricular muy rápida) en un paciente joven puede indicar la presencia de un **Síndrome de Wolff-Parkinson-White** con una vía accesoria que conduce los impulsos auriculares de la FA directamente a los ventrículos, bypassando el nodo AV. Esto es una emergencia médica.

Clasificación de la Fibrilación Auricular

La clasificación ayuda a guiar el manejo, aunque no siempre define la necesidad de anticoagulación.

Según el Inicio:

- **De inicio reciente:** - **Con hemodinamia estable:** El paciente está asintomático o con síntomas leves, sin signos de shock, insuficiencia cardíaca aguda o isquemia. - **Con hemodinamia inestable:** Requiere cardioversión eléctrica inmediata. Se presenta con shock, hipotensión, edema pulmonar agudo, isquemia miocárdica activa o compromiso de conciencia.

Según la Duración y Recurrencia:

- **Paroxística:** Cesa espontáneamente en menos de 7 días (generalmente en menos de 48 horas). Puede ser recurrente. - **Persistente:** Dura más de 7 días y requiere intervención (farmacológica o eléctrica) para terminar. - **Permanente:** Ha durado más de 12 meses, o se ha decidido no intentar restaurar el ritmo sinusal.

NOTA CLÍNICA

La clasificación en paroxística, persistente o permanente **no tiene implicancia directa** en la decisión de anticoagular al paciente. La indicación de anticoagulación se basa en el riesgo embólico individual del paciente, evaluado con escalas como el **CHA2DS2-VASc**.

NOTA CLÍNICA

El **R4** es un ruido cardíaco patológico, audible en la diástole tardía, asociado a una contracción auricular vigorosa contra un ventrículo poco distensible (ej. **Cardiopatía hipertensiva**, miocardiopatía hipertrófica). La **onda 'a' del pulso venoso yugular** refleja la contracción de la aurícula derecha. La onda 'v' (o 'b') se relaciona con el llenado de la aurícula derecha durante la sístole ventricular.

Preguntas Clave en el Manejo de la FA (a abordar en próximos videos)

- **Anticoagulación:** ¿Es necesaria? ¿Con qué fármaco? ¿Por cuánto tiempo?
- **Control de ritmo vs. Control de frecuencia:** ¿Debo intentar restaurar y mantener el ritmo sinusal (control de ritmo) o solo controlar la frecuencia cardíaca ventricular (control de frecuencia)?
- **Fármacos:** ¿Qué fármacos son los más adecuados para el control de la frecuencia o el ritmo?
- **Cardioversión:** ¿Cuándo está indicada (inmediata, electiva) o cuándo no se debe realizar?

Estas preguntas fundamentales guiarán el manejo clínico de la FA.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 68 años consulta por palpitaciones irregulares de 3 semanas. ECG no muestra ondas P e intervalos R-R irregulares a FC 115 lpm."

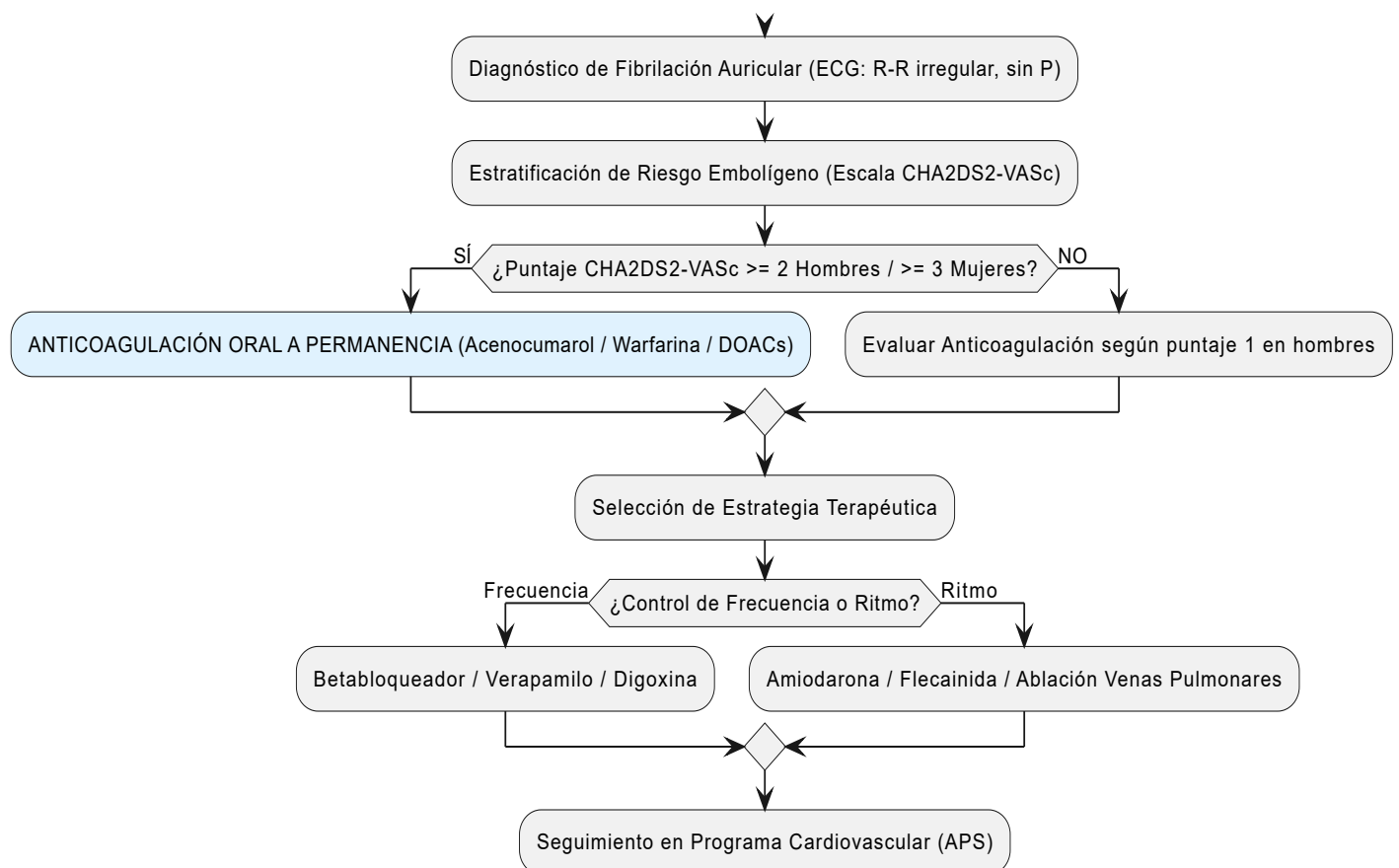
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

La FA requiere ausencia de ondas P y ritmo irregularmente irregular. En paciente estable, controlar FC y evaluar CHA₂DS₂-VASc para anticoagulación.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- FA = arritmia más frecuente. Causa más frecuente: hipertensión arterial.
- Estenosis mitral: la que MÁS dilata la aurícula izquierda y MÁS riesgo embólico tiene.
- Clínica: palpitaciones, IC, embolias, pulso irregularmente irregular, sin R4, sin onda A.
- ECG: ritmo irregular + ausencia de onda P (fibrilación de la línea de base) + QRS angosto.
- Diferencia con flutter: en FA la línea de base es fibrilada y desorganizada; en flutter hay ondas P en serrucho.
- Complicaciones más importantes: insuficiencia cardíaca y embolias.
- Clasificación: inicio reciente (estable/inestable) y crónica (paroxística/persistente/permanente).
- FA con Wolf-Parkinson-White puede tener frecuencias muy altas.
- La causa incide mucho en el pronóstico de la FA.

FIGURA 1.5B: ESTRATEGIA GLOBAL AF-CARE DE MANEJO DE FIBRILACIÓN AURICULAR



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FIBRILACIÓN AURICULAR)**PREGUNTA 1**

Paciente de 72 años hipertenso consulta por palpitaciones de inicio hace 6 horas. Al examen: pulso irregular a 130 lpm. ECG muestra ausencia de onda P, fibrilación de la línea de base y QRS angosto. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Flutter auricular
- B)** Fibrilación auricular de reciente comienzo
- C)** Taquicardia paroxística supraventricular
- D)** Taquicardia ventricular
- E)** Taquicardia sinusal

PREGUNTA 2

¿Cuál de las siguientes valvulopatías se asocia con MAYOR frecuencia a fibrilación auricular y MAYOR riesgo de fenómenos embólicos?

- A)** Insuficiencia aórtica
- B)** Estenosis mitral
- C)** Estenosis aórtica
- D)** Insuficiencia tricuspídea
- E)** Insuficiencia mitral

RESUMEN: FIBRILACIÓN AURICULAR

La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente. Sus causas principales son todas las que dilatan la aurícula izquierda: la hipertensión arterial (causa más frecuente), las valvulopatías (especialmente la estenosis mitral que es la que más dilata la aurícula y más riesgo embólico tiene), y otras cardiopatías. También los estados hiperdinámicos (hipertiroidismo, sepsis, SCA, TEP, anemia, cocaína) y las causas idiopáticas que son frecuentes en jóvenes y de mejor pronóstico. La clínica incluye palpitaciones, insuficiencia cardíaca, fenómenos embólicos (ACV, isquemia mesentérica, embolia de extremidades), pulso irregularmente irregular, ausencia de R4 y ausencia de onda A del pulso venoso. El diagnóstico es con ECG que muestra ritmo irregular, ausencia de onda P reemplazada por fibrilación de la línea de base, y QRS angosto (salvo bloqueo de rama asociado). La frecuencia puede ser normal, alta o muy alta, especialmente si hay Wolf-Parkinson-White. La clasificación es de inicio reciente (con hemodinamia estable o inestable) y crónica (paroxística, persistente, permanente). Las preguntas fundamentales del manejo son: anticoagular o no, control de ritmo versus frecuencia, qué fármacos usar, y cuándo cardiovertir.